

KC桌面——外资精译

美洲医疗保健：ASCO 周末要点

我们正在参加美国临床肿瘤学会（ASCO）会议。SMMT 的合作伙伴 Akeso 在全体会议上公布了 HARMONi-6 晚期 III 期总生存期数据（同时发表于《柳叶刀》），其中 ivonescimab + 化疗在初治鳞状非小细胞肺癌中显示出具有统计学意义和临床意义的 27.9 个月获益，而 Tevimbra（抗 PD-1）+ 化疗为 23.7 个月，风险比（HR）为 0.66（单侧 $p=0.0017$ ），超过了我们根据投资者交流得出的约 0.72 的阈值和医生低于 0.80 的阈值（见此处我们的要点）。我们覆盖范围内的公司其他关键报告包括：IMNM（varegacestat 在硬纤维瘤中的完整 III 期结果进一步支持其优于默克雪兰诺的 Ogsiveo 的同类最佳地位，注意到所有 alpha 控制的次要终点，包括关键疼痛缓解指标均达到统计学显著性）、GILD（GILD 的 TUB-040 更新的 I 期数据继续显示出令人鼓舞的结果，与 ESMO 之前的更新一致，并支持其在卵巢癌中潜在的差异化特征；我们还注意到 Trodelvy 在 1L TNBC 中的 III 期亚组分析）、INCY（tafasitamab 在 1L DLBCL 中的完整 III 期结果——考虑到竞争动态，我们认为对于某些患者，例如 GCB 亚型疾病患者，这是一种潜在的差异化选择）、SMMT（全球 II 期转移性结直肠癌中期数据显示在选定的 III 期 ivonescimab 剂量下具有持久的疗效，包括标志性的 9 个月 PFS 率为 76.1%，支持正在进行的全球 III 期 HARMONi-GI3 研究），以及迪哲医药和强生的报告，对 AVBP 具有解读意义。

Summit Therapeutics（SMMT，买入，Salveen Richter）

Ivonescimab 联合化疗对比替雷利珠单抗联合化疗治疗既往未经治疗的晚期鳞状非小细胞肺癌：III 期 HARMONi-6 试验的总生存期结果

SMMT 的合作伙伴 Akeso 在全体会议上分享了来自单区域（中国）III 期 HARMONi-6 研究的 ivonescimab（ivo；一种 PD-1xVEGF）+ 化疗对比 Tevimbra（ONC 的抗 PD-1，类似于 MRK 的 Keytruda）+ 化疗在初治鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）中的总生存期（OS）数据（见此处我们演示文稿的完整要点）。回顾一下，Akeso 此前已分享了该研究的无进展生存期结果（链接），其中该联合疗法在鳞状 NSCLC 患者中显示出显著且具有临床意义的 PFS 获益——11.1 个月对比 6.9 个月——风险比（HR）为 0.60（ $p<0.0001$ ）。根据今天公布的晚期摘要，ivo + 化疗显示出具有统计学意义的总生存期获益，为 27.9 个月，对比 Tevimbra（抗 PD-1，类似于 MRK 的 Keytruda）+ 化疗的 23.7 个月，死亡风险降低 34%（HR=0.66；95% CI，0.50 至 0.87；单侧 $P=0.0017$ ）。Ivo + 化疗的 OS 获益在各亚组中一致，其中在 PD-L1 阴性患者（肿瘤比例评分（TPS） $<1\%$ ）中，中位 OS 为未达到对比 18.6 个月（HR，0.64；95% CI，0.43 至 0.96），在 PD-L1 TPS $\geq 1\%$ 的患者中，中位 OS 为未达到对比 27.3 个月（HR，0.68；95% CI，0.46 至 0.99）。在安全性方面，ivo 显示出可控的安全性特征，与既往 ivonescimab 联合化疗的 III 期研究一致。与之前公布的数据截止相比，本次数据截止的 HARMONi-6 研究中未发现新的安全性信号。

总体而言，根据我们的尽职调查和投资者交流，这些数据超过了 HR <0.72 的阈值，我们认为令人印象深刻，注意到这是首次在初治 NSCLC 的 III 期研究中，任何方案显示出优于 PD-1 + 化疗（全球标准治疗）的统计学显著获益（见此处我们的完整要点）。今天的 HARMONi-6 结果进一步证实了 ivo 的 PFS 获益转化为 OS，并为 SMMT 正在进行的全球 III 期 HARMONi-3 研究（ivo + 化疗对比 Keytruda + 化疗治疗初治 NSCLC）提供了积极的解读意义。SMMT 将在 2025 年下半年公布 HARMONi-3 研究的最终 PFS 和中期 OS 数据。

我们还注意到 SMMT 和 Akeso 关于 ivo 在结直肠癌中的早期 I/II 期数据的海报展示，对正在进行的全球 III 期 HARMONi-GI3 研究具有解读意义：

Ivonescimab (ivo) 联合奥沙利铂 + 氟尿嘧啶 (5-FU) + 亚叶酸钙 (mFOLFOX6) 用于不可切除的转移性结直肠癌 (mCRC) 患者：一项 II 期研究。

我们注意到在 ASCO 的海报环节中，关键意见领袖对 II 期海报表现出显著兴趣。我们认为这些数据令人鼓舞，并为 SMMT 正在进行的 III 期 HARMONi-GI3 研究提供了积极的解读意义，该研究正在评估 20mg/kg 的 ivo + mFOLFOX6 在初治 mCRC 中的应用。根据报告者的说法，使用选定的更高 III 期剂量时毒性略有增加，包括 VEGF 相关毒性，这是可控的，因为目前初治 mCRC 的标准治疗是贝伐珠单抗 + 化疗，因此医生习惯于管理出现此类不良事件的患者。此外，我们注意到这些数据似乎与 PFE 的竞争性 PD-1xVEGF 分子 PF4404 相当或更优，后者在 1L mCRC 的 II 期研究中显示出确认的 ORR 为 57.1%，DCR 为 95.2%（链接）。

Immunome (IMNM, 买入, Salveen Richter)

RINGSIDE：一项关于 varegacestat 治疗进展性硬纤维瘤的 III 期随机、安慰剂对照试验

IMNM 公布了 gamma 分泌酶抑制剂 varegacestat 在硬纤维瘤中的 III 期 RINGSIDE 研究的完整结果。回顾一下，IMNM 此前已公布了积极的 III 期顶线数据，显示与安慰剂相比，无进展生存期 (PFS；风险比 (HR) = 0.16； $p < 0.0001$) 具有统计学显著获益，客观缓解率 (ORR) 为 56%，肿瘤体积缩小 83%，巩固了 varegacestat 优于默克雪兰诺的 Ogsiveo 的同类最佳地位。本周末在 ASCO 的口头报告还包括亚组分析和关键次要终点数据，包括生活质量影响，我们注意到所有 alpha 控制的次要终点均显示出 varegacestat 对比安慰剂的统计学和临床显著优越性。在疼痛缓解这一关键终点上，根据广泛疼痛指数 (WPI)，varegacestat 显示出与安慰剂相比具有统计学显著差异的 -2.42。报告的关键意见领袖指出，虽然该研究并非为检测亚组间的统计学显著性而设计，但 varegacestat 确实在所有检查的亚组中均显示出 PFS 获益，包括具有 APC 和 CTNNBP1 突变的患者、肿瘤较大的患者以及既往接受过硬纤维瘤治疗的患者。

在会议讨论环节中，主导讨论的 KOL 旨在根据 Ph3 RINGSIDE 和 Ph3 DeFi 研究的现有数据，将 varegacestat 与 Ogsiveo 进行比较。KOL 指出，在比较两项研究的瀑布图时，接受 varegacestat 治疗的患者显示出更深的缓解，在肿瘤体积缩小方面具有优越性，并且 varegacestat 在疼痛缓解方面似乎表现出更好、更快的改善。在安全性方面，KOL 强调了 varegacestat 在卵巢毒性方面的优越性 (varegacestat 组为 56%，而 Ogsiveo 组为 76%)，但指出其他不良事件的总体水平相似，且 varegacestat 的剂量减少次数更多 (DeFi 研究中 varegacestat 组为 80%，而 Ogsiveo 组为 42%)。主导讨论的 KOL 还指出，两种药物似乎均对腹腔内和腹腔外疾病显示出疗效。KOL 提出的一个悬而未决的问题是，如何定义 GSI 类药物在疗效与毒性之间取得平衡的最佳治疗持续时间——KOL 强调了 Ogsiveo 近期的 3 年数据，指出长期使用仅观察到 3 例额外缓解，因此 KOL 认为持续治疗的获益仍不明确。

总体而言，我们认为这些数据进一步证明了 varegacestat 同类最佳的潜力。我们注意到，在 Ph3 DeFi 研究中，varegacestat 的 1 年/2 年无进展生存率分别为 94.2%/88.9%，而 Ogsiveo 为 85%/76%，同时根据 KOL 的意见，在包括疼痛在内的关键患者结局指标上也有获益。虽然发表演讲的 KOL 指出缺乏头对头研究，并且鉴于 Ogsiveo 和 varegacestat 均属于 GSI 类药物，两者可能具有相似性，但 KOL 确实强调了 varegacestat 每日一次的给药方案是其差异化优势。主导会议讨论环节的 KOL 还强调了 varegacestat 的优越性，同时提醒注意跨试验比较的局限性。我们认为，根据疗效数据、每日一次给药对比 Ogsiveo 每日两次给药（考虑到医生/患者偏好更简便的方案），以及在绝经前女性中观察到的约 55.6% 的卵巢毒性发生率（对比 Ogsiveo 的约 75%），varegacestat 具有差异化优势。varegacestat 的新药申请已于第二季度提交，IMNM 计划于 2026 年底前向欧洲药品管理局提交 varegacestat 的上市许可申请。鉴于其特性，我们预计其上市表现将优于 Ogsiveo，并预测其全球峰值销售额在 2037 年将达到 16 亿美元。

吉利德科学 (GILD, 中性, Salveen Richter)

NAPISTAR 1-01：新型靶向NaPi2b的exatecan

ADC药物TUB-040单药治疗铂耐药卵巢癌患者的1期剂量递增研究结果

在正在进行的ASCO会议上，公布了TUB-040治疗铂耐药卵巢癌的I/IIa期NAPISTAR 1-01试验（NCT06303505）的最新数据。TUB-040是一种新型抗体药物偶联物，靶向钠依赖性磷酸盐转运蛋白NaPi2b，采用拓扑异构酶I抑制剂（exatecan）作为载荷，药物抗体比为8。

背景。回顾一下，NaPi2b在高级别浆液性卵巢癌和非小细胞肺癌中过表达。TUB-040是一种靶向NaPi2b的DAR8 ADC，由人源化Fc沉默IgG1单克隆抗体通过可裂解、半胱氨酸选择性、稳定、可溶性介导的P5连接子与exatecan偶联而成，具有优异的稳定性和良好的生物物理ADC特性。在临床前研究中，TUB-040可诱导有效的抗原特异性细胞毒性，并表现出强大的旁观者效应。

NAPISTAR 1-01是一项在未经生物标志物筛选的PROC和NSCLC患者中开展的1/2a期研究。在PROC患者中，TUB-040以Q3W方案进行剂量递增（范围0.5-5.3 mg/kg），直至出现疾病进展或不可接受的毒性。截至2025年12月1日，共有67名PROC患者接受了TUB-040治疗，中位治疗周期数为10个（1-25），中位暴露持续时间为213天（21-546），42名（63%）患者仍在治疗中。中位年龄：62岁（34-81），ECOG PS 0-1，中位既往治疗线数：4线（1-7），既往治疗包括贝伐珠单抗（84%）、PARP抑制剂（76%）和mirvetuximab soravtansine（13%）。

疗效。疗效分析聚焦于46名接受1.67至3.3 mg/kg剂量水平治疗的患者。该人群既往接受过大量治疗，中位既往治疗线数为4线，包括贝伐珠单抗（84%）和PARP抑制剂（76%）。

确认的总体缓解率：61%（包括两例确认的完全缓解）。■ 未确认的总体缓解率：67%。■

疾病控制率：96%。中位无进展生存期：在更广泛的67名患者群体（剂量0.5 – 5.3

mg/kg）中为11个月。这显著优于PROC患者约5个月的历史标准治疗中位无进展生存期。■

CA-125缓解率：81%的可评估患者（34/42）显示出生化

缓解。

缓解持久性：79%的缓解者维持缓解超过6个月，57%超过12个月。中位缓解持续时间尚未达到。

安全性。TUB-040的安全性特征似乎与NaPi2b和拓扑异构酶抑制剂类别的其他ADC有所不同，特别是在脱靶毒性方面。

■ 常见不良事件：最常见的治疗期间出现的不良事件为恶心（78%）、疲劳（54%）和中性粒细胞减少症（43.5%）。■ 血液学毒性：在1.67 – 3.3 mg/kg剂量水平，26%的患者发生3级或以上中性粒细胞减少症。还报告了3级+贫血（13%）和血小板减少症（4%）。差异化特征：值得注意的是，没有出现临床相关的间质性肺病/肺炎（仅6.5%为1级，均已缓解）、眼部毒性或周围神经病变。这种缺乏“类效应”毒性的现象表明其具有更宽的治疗窗口和联合治疗的潜力。

总体而言，我们认为这些数据令人鼓舞，与之前在ESMO上公布的数据基本一致（注意之前已确定最大耐受剂量为4.4mg/kg），并认为该药物是卵巢癌领域领先的新兴疗法之一。会议上的医生反馈非常积极。剂量优化正在进行中。GILD已指出可能在2027财年启动注册性研究。

ASCENT-04：戈沙妥珠单抗 + 帕博利珠单抗对比化疗 +

帕博利珠单抗在既往未经治疗的PD-L1+转移性三阴性乳腺癌患者中按生物标志物亚组分析的疗效

ASCENT-03：戈沙妥珠单抗对比化疗在既往未经治疗、不适合接受PD-(L)1抑制剂治疗的晚期三阴性乳腺癌患者中按生物标志物亚组分析的疗效

Trodelvy（戈沙妥珠单抗）在转移性三阴性乳腺癌一线治疗中的关键数据得到强调，主要来自对3期ASCENT-03和ASCENT-04试验的更新亚组分析和探索性分析。回顾一下，这些报告是在先前于《新英格兰医学杂志》发表

结果之后进行的。

ASCENT-04 : Trodelvy + Keytruda (PD-L1阳性)

ASCENT-04 试验 (KEYNOTE-D19) 评估了 Trodelvy

联合帕博利珠单抗对比标准治疗 (SOC) 化疗联合帕博利珠单抗，用于既往未经治疗的 PD-L1 阳性 (CPS $\geq$ 10) 转移性三阴性乳腺癌 (mTNBC) 患者。

■ 主要疗效：该联合方案在无进展生存期 (PFS) 方面显示出具有统计学意义的改善。

中位 PFS：11.2 个月对比对照组的 7.8 个月 (HR：0.65； $p < 0.001$)。

风险降低：疾病进展或死亡风险降低 35%。

■ ASCO 亚组亮点：在 2026 年会议上公布的数据显示，在所有 Trop-2 表达四分位组 (Q1 – Q4) 中均观察到 PFS 获益，但在高表达组中获益更强：

高 Trop-2 (Q4)：中位 PFS 达到 16.6 个月对比 9.2 个月 (HR：0.57)。低 Trop-2 (Q1)：中位 PFS 为 9.3 个月对比 9.0 个月 (HR：0.81)，表明即使在低表达肿瘤中也有获益。

安全性：安全性特征可控，且与两种药物已知的安全性特征一致，43% 的患者发生 $\geq$ 3 级中性粒细胞减少症。

ASCENT-03 : Trodelvy 单药治疗 (PD-L1 阴性/不适合免疫治疗)

ASCENT-03 试验聚焦于不适合接受 PD-(L)1 抑制剂治疗 (主要为 PD-L1 阴性或在治愈性背景下接受既往免疫治疗后进展) 的一线 mTNBC 患者。

主要疗效：Trodelvy 单药治疗显著优于医生选择的化疗方案。

中位 PFS：9.7 个月对比 6.9 个月 (HR：0.62； $p < 0.0001$)。缓解持续时间 (DOR)：Trodelvy 组为 12.2 个月，化疗组为 7.2 个月。

■ ASCO 2026 亚组亮点：在关键生物标志物 (包括肿瘤 BRCA (tBRCA) 状态和 HER2-low 状态) 中均维持了获益。

□ tBRCA 野生型：HR 0.70。□ HER2-Low：HR 0.74。Trop-2

四分位组：在所有四分位组中均观察到获益，HR 范围为 0.54 至 0.84。

总体而言，我们认为这些更新是增量性的 (鉴于此前已公布结果)。回顾一下，NCCN 指南已于今年早些时候更新以反映这些数据 (Trodelvy 单药和 Trodelvy + Keytruda 现分别成为不适合免疫治疗的 PD-L1 阳性一线 TNBC 患者的 1 类选择)。回顾一下，Trodelvy 已是二线 TNBC 的标准治疗。我们正在关注与 AZN 的 Datroway 的竞争动态——该药已于 5 月获批用于不适合免疫治疗的一线 TNBC 患者。我们注意到 Trodelvy 的 OS 数据尚不成熟，但 Datroway 实现了约 5 个月的获益 (约 24 个月对比约 19 个月；HR = 0.70)。我们预计临床医生可能会根据毒性特征 (中性粒细胞减少症/腹泻对比口腔炎/间质性肺病) 以及患者的具体 PD-L1 状态在这两种药物之间进行选择。

Incyte (INCY, 中性, Salveen Richter)

frontMIND：tafasitamab (Tafa) 联合来那度胺 (Len) 和 R-CHOP 用于新诊断的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 患者的 3 期研究。

背景。回顾一下，tafasitamab 是一种靶向恶性 B 细胞上 CD19 的 Fc 工程化单克隆抗体，对免疫效应细胞具有增强的亲和力，可驱动抗体依赖性细胞毒性 (ADCC)、抗体依赖性细胞介导的吞噬作用 (ADCP) 和直接细胞毒性。来那度胺通过扩增和激活效应细胞并增强这些机制，与 tafasitamab 产生协同作用。尽管一线 R-CHOP 是弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 的标准治疗，但约 40% 的高危患者未能治愈。

frontMIND (NCT04824092) 是一项全球性、多中心、安慰剂对照、双盲、随机 3 期研究，评估 Tafa-Len-R-CHOP 对比 R-CHOP 用于既往未经治疗、年龄 18 – 80 岁、高中危或高危 (IPI 3 – 5, 若 ≤ 60 岁则为 aaIPI 2 – 3) DLBCL 或高级别 B 细胞淋巴瘤 (HGBL) 患者。共 899 名患者按 1:1 随机分配，接受 6 个周期的 Tafa-Len-R-CHOP 或 R-CHOP 加安慰剂治疗。主要终点是无进展生存期 (PFS)，关键次要终点是无事件生存期 (EFS) 和总生存期 (OS)。

疗效

■ PFS (主要终点)：Tafa-Len-R-CHOP 对比 R-CHOP 显著延长了 PFS，风险比 (HR) 为 0.75 (95% CI：0.59 – 0.96； $P=0.0194$)，代表进展或死亡风险降低 25%。2 年 PFS 率为 71.1% 对比 62.9% ($\Delta=8.2\%$)，3 年 PFS 率为 67.3% 对比 60.7% ($\Delta=6.6\%$)。

EFS：Tafa-Len-R-CHOP 组显著改善 (HR 0.79；95% CI：0.64 – 0.97； $P=0.0260$)；2 年 EFS 为 65.0% 对比 56.7%。□ 中心确认亚型 ($n=773$)：PFS 获益更为显著 (HR 0.68；95% CI：0.52 – 0.88)，2 年 PFS 差异为 10.5%。亚组分析：在预先指定的亚组中观察到一致的 PFS 获益趋势，包括 ABC 样和 GCB 样细胞起源亚型、IPI 风险组、地理区域和年龄组。

OS (中期)：观察到阳性趋势 (HR 0.85；95% CI：0.63 – 1.14； $P=0.2703$)；2 年 OS 为 84.1% 对比 80.5%。■ 缓解率：两组间的 ORR (80.4% 对比 76.1%) 和 PET 阴性 CR 率 (均为 65.2%) 相似，Tafa-Len-R-CHOP 组的部分缓解率数值更高。

安全性

■ 两组几乎所有患者均报告了治疗期间出现的不良事件 (TEAE) (98.6% 对比 97.1%)。Tafa-Len-R-CHOP 组 ≥ 3 级 TEAE 的发生率更高 (86.7% 对比 76.1%)，严重 TEAE (50.1% 对比 38.9%) 和致命性 TEAE (5.9% 对比 3.8%) 也是如此。最常见的 ≥ 3 级事件是血细胞减少症 (中性粒细胞减少症、贫血、血小板减少症)，严重发热性中性粒细胞减少症的发生率为 13.3% 对比 9.8%。

- 致命性 TEAE 基本平衡，但试验组 COVID-19 和败血症的发生率更高。

■ 因 TEAE 导致的停药率相似 (5.2% 对比 5.4%)。

- 重要的是，添加 tafasitamab 和来那度胺并未影响 R-CHOP 骨架方案的给药，在 6 个周期中，大多数成分的中位相对剂量强度为 100%。

关键结论

- 在既往未经治疗的高危 DLBCL 和 HGBL 患者中，Tafa-Len-R-CHOP 对比 R-CHOP 显著延长了 PFS (HR 0.75)。

- 在关键预先指定的亚组中观察到一致的 PFS 优势趋势。

- Tafa-Len-R-CHOP 增加的 safety 事件管理良好，且未影响 R-CHOP 骨架方案的给药。

- 这些结果支持 Tafa-Len-R-CHOP 作为高危 DLBCL 或 HGBL

患者 (无论细胞起源分子亚型如何) 新的一线标准治疗选择。完整稿件已发表于《柳叶刀》。

总体来看，我们认为这些数据令人鼓舞 (继先前的顶线公告之后)，INCY 计划于今年晚些时候提交监管申请。尽管我们注意到会议现场参会人数有限/KOL 关注度不高，但核心争论焦点在于 Tafa-Len-R-CHOP 将如何与 Pola-R-CHP 竞争，成为高危 DLBCL 的一线优选方案。回顾一下，Pola-R-CHP 是对标准 R-CHOP 方案的改良——它用抗体药物偶联物 (ADC) polatuzumab vedotin 替代了长春新碱，目前被视为与 R-CHOP 并列的标准治疗方案，也是 Tafa-Len-R-CHOP 等新联合方案的主要参照基准。KOL 们对 Tafa-Len-R-CHOP 在不同分子亚型中的疗效持乐观态度。

ArriVent Biopharma (AVBP, 买入, Corinne Johnson)

我们强调ASCO 2026的两项报告对AVBP的参考意义：(1) Dizal公司sunvozertinib用于1L EGFR外显子20插入突变NSCLC的Ph3 WU-KONG28数据，以及(2) JNJ公司Rybrevant + Lazcluze用于1L非典型EGFR NSCLC的CHRYSLIS-2 Cohort C更新数据。

在ASCO 2026上，Dizal公布了Ph3 WU-KONG28数据，显示sunvozertinib (sunvo) 单药治疗在1L EGFR外显子20插入突变中实现了10.3个月的中位无进展生存期 (mPFS)，而化疗组为7.5个月，客观缓解率 (ORR) 为68.1%。我们认为这对AVBP的firmonertinib (firmo) 在Ph3 Furvent研究前是逐步利好的，因为7.5个月的化疗对照组 (强化了我们约8个月FURVENT的假设) 和10.3个月的药物mPFS提供了一个有用的基准，并未对firmonertinib的疗效或安全性设定过高的门槛。我们最近的Furvent统计分析表明，firmo的mPFS超过11个月 (基础情形约16个月，依赖于假设约8个月的对照组结果)，这优于sunvo，并与/优于Rybrevant的11.4个月mPFS具有竞争力。此外，sunvo和firmo具有相似的作用机制——均为口服、不可逆、突变选择性靶向外显子20插入的EGFR TKI——因此积极的Ph3结果进一步降低了firmo这一机制的风险。

JNJ报告了Rybrevant + Lazcluze用于1L非典型EGFR NSCLC的CHRYSLIS-2 Cohort C更新数据，显示ORR为57%，中位总生存期 (mOS) 约为41个月。我们认为这对AVBP是逐步利好的，因为：(1) 在非随机化跨试验比较中，firmo在数值上似乎更优，在可比非典型EGFR患者中 (Ph1b PACC研究) 实现了82%/68%的ORR/cORR (n=22)；(2) JNJ的研究入组了相对更对药物敏感的非典型EGFR人群，主要集中在经典非典型突变如G719X、L861Q和S768I，并排除了外显子20插入突变，而我们认为firmo的开发目标是更难治疗的PACC突变和外显子20插入突变；(3) 成熟的约3.5年OS基准继续验证了非典型EGFR作为一个有意义且持久的商业靶点，降低了更广泛市场机会的风险。

估值与风险

AVBP (买入)。我们的12个月目标价为34美元，基于DCF分析，假设贴现率为15%，终端增长率为2%；这些假设反映了AVBP的临床开发阶段和适度的长期扩张机会。主要下行风险包括：(1) firmonertinib在针对领先的EGFR外显子20插入/PACC突变/经典突变项目的关键试验中出现负面临临床结果，(2) 来自已确立疗法的竞争态势比预期更差，(3) 监管延迟和/或FDA批准标准的意外变化，以及(4) 在实现盈利前因现金需求而产生的财务风险。

GILD (中性)。我们的12个月目标价为130美元，基于100% DCF分析 (3% TGR, 8% WACC)。下行风险：临床或监管失败或延迟 (特别是长效HIV产品组合)；HIV市场的逆风/干扰；Biktarvy或Yeztugo销售增长弱于预期；竞争对手药物的成功。上行风险：市场增长和/或渗透率高于我们的假设；本十年下半年HIV市场仿制药的定价压力较小；竞争对手药物的临床或监管失败或延迟。

INCY (中性)。我们的12个月目标价为100美元，基于100% DCF (9% WACC和1% TGR)。风险：上行风险：J akafi生命周期管理项目进展快于预期，包括mCALR的积极数据、SNDX合作的Niktivmo上市好于预期，或Opzelura的更高采用率及在扩展适应症中的获批。下行风险：鉴于对管线开发的重视，任何基础临床项目的失败或安全事件、监管延迟，以及来自竞争性肿瘤学/GVHD项目的潜在威胁。Opzelura面临的逆风。

SMMT (买入)。估值：我们的12个月目标价为41美元，基于85%/15%的风险调整DCF价值35美元 (WACC为18%，TGR为2%) 与理论并购价值73美元 (2031年预期销售额的11倍) 的混合估值。下行风险：临床、技术和制造风险——合作伙伴Akeso在中国产生的数据可能无法转化为SMMT的全球临床研究；中美贸易关系可能对供应链运营产生不利影响；意外的安全问题或临床延迟可能推迟上市时间表。监管风险——未能获得适应症或地区的监管批准可能影响商业成功，并对我们的销售预测构成重大下行风险。竞争风险——竞争对手的PD-1/L1xVE GF资产可能展示出更优数据，或临床开发进展快于预期。融资风险/稀释。

IMNM (买入)。估值：我们的12个月目标价为35美元，基于85%/15%的风险调整DCF价值27美元 (WACC为17%，TGR为5%) 与理论并购部分83美元 (IM-1021销售满两年后2031年预期销售额的11倍) 的混合估值。下行风险：临床/技术风险：如果IMNM的目标肿瘤学项目未能展示持续且持久的获益，其长期潜力可能因医生采用有

限而受到抑制，意外的安全问题或临床延迟可能推迟上市时间表。竞争风险：竞争对手的资产可能临床开发进展快于预期，或产生看似优于IMNM资产的数据。监管风险：无法获得适应症或地区的监管批准，监管要求和时间表可能影响试验范围和时间表。商业风险：尽管获得上市批准，但由于生产规模扩大可能带来的制造困难，IMNM的产品可能无法取得商业成功。融资/稀释风险，以及低于预期的销售额也将对我们的预测构成下行风险。

公众号：KC桌面